



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
KOMITE KEPERAWATAN**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 735.2/I-PDM/KPW/VIII/2025

Tentang
Pedoman Kerja Komite Keperawatan

Disusun Oleh :
Penanggung Jawab Komite Keperawatan



Fariz Tiarawan Fadil Cahyono, S.Kep.Ns

Disetujui Oleh:

Authorized Person



Dr.dr. Aslichah, M.Kes.AFP

Ditetapkan Oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat tuhan yang maha esa karena atas rahmatnya pedoman kerja komite keperawatan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan rs. Prima husada.

Pedoman kerja komite keperawatan ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 dengan melalui berbagai review dan update dari beberapa literatur. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada contributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan pedoman kerja komite keperawatan ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit prima husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN KERJA KOMITE KPERAWATAN

1. Fariz Tiarawan Fadil Cahyono, S.Kep.Ns
2. Lola Novira Risdiyanti, Amd.Kep
3. Arif Setya Pamuji, A.Md.Kep
4. Saghita Puspita Sari Amd.Kep
5. Dhora Putri Meryda S.Kep.Ns
6. Murwani Suryaning S., Amd. Kep
7. Sherly Rosita, S. Kep. Ns
8. Amilatul Kholifah, Amd.Kep
9. Siti Zaimah Amd.Keb
10. Puput Sekar Nariratih, Amd.Keb, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 3

DAFTAR ISI 5

LAMPIRAN..... 9

BAB I..... 9

PELAKSANAAN KOMITE KEPERAWATAN 9

BAB II..... 11

ORGANISASI KOMITE KEPERAWATAN 11

BAB III..... 20

KEGIATAN DAN TATA LAKSANA 20

 3.1 Batasan – Batasan Dalam Pelaksanaan Komite Keperawatan 20

 3.2 Kegiatan Pelaksanaan Komite Keperawatan 20

 3.3 Tatalaksana Komite Keperawatan 21

BAB IV 22

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN..... 22

 4.1 Monitoring..... 22

 4.2 Evaluasi 22

 4.3 Laporan 22

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 735.2/I-PDM/KPW/VIII/2025**

TENTANG

PEDOMAN KERJA KOMITE KEPERAWATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan pengakuan tentang kualitas pelayanan yang dilakukan, rumah sakit harus membuat pedoman kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. bahwa agar pelaksanaan komite keperawatan dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman kerja komite keperawatan sebagai landasan untuk berjalannya suatu program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan poin b, maka dipandang perlu ditetapkan panduan kerja komite keperawatan dengan keputusan direktur rumah sakit prima husada malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor hk.02.02/d/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/dpm/i-kep/dir/i/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/i-kep/dir/v/2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE KEPERAWATAN**

Pasal 1

- (1) Komite keperawatan dibentuk untuk membantu direktur rumah sakit dalam meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan dan kebidanan melalui tata kelola klinis yang baik, kredensial, pemeliharaan mutu profesi serta pembinaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Segala yang berhubungan dengan rapat komite keperawatan diatur oleh sekretaris komite keperawatan, termasuk persiapan, dokumentasi, dan tindak lanjut hasil rapat.
- (3) Komite keperawatan membina hubungan kerja dengan komite, instalasi, dan unit kerja lain yang terkait dalam upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien.
- (4) Rapat rutin komite keperawatan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi dan pelayanan rumah sakit.

BAB II

ORGANISASI DALAM KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 2

Rumah sakit menerapkan mekanisme koordinasi yang melibatkan pimpinan rumah sakit dan komite keperawatan.

Komite keperawatan terdiri atas:

- a. Ketua komite keperawatan.
- b. Sekertaris komite keperawatan.
- c. Subkomite kredensial.
- d. Subkomite mutu profesi.
- e. Subkomite etika dan disiplin profesi
- f. Anggota komite keperawatan sesuai kebutuhan rumah sakit.

Pasal 3

Rumah sakit menetapkan anggota komite keperawatan dengan kriteria:

- a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
- b. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang keperawatan atau kebidanan.
- c. Memiliki integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan.
- d. Bersedia melaksanakan tugas dan fungsi komite keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Masa jabatan ketua, sekertaris, dan anggota komite keperawatan ditetapkan berdasarkan surat keputusan direktur rumah sakit dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 5

Komite keperawatan mempunyai tugas membantu direktur rumah sakit dalam penyelenggaraan tata kelola klinis keperawatan melalui mekanisme :

- a. Kredensial.
- b. Pemeliharaan Mutu Profesi.

c. Pembinaan Etika Dan Disiplin Profesi

Pasal 6

Komite keperawatan berfungsi untuk melakukan proses krendial dan rekredensial tenaga keperwatan dan kebinan, dan juga melakukan evaluasi kompetensi tenaga keperawatan dan kebidanan .

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Komite keperawatan melakukan pencatatan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas di rumah sakit kepada pimpinan rumah sakit.

Pasal 8

Peraturan direktur rumah sakit prima husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 06 Agustus 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr.Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 735.2/LPDM/KPW/VIII/2025
TENTANG PEDOMAN KERJA
KOMITE KEPERAWATAN

PEDOMAN KERJA KOMITE KEPERAWATAN

BAB I

PELAKSANAAN KOMITE KEPERAWATAN

Pelaksanaan komite keperawatan menjadi salah satu elemen penting dalam tata kelola klinis (*clinical governance*) rumah sakit. Melalui berbagai kegiatan yang terencana dan terarah, komite keperawatan berupaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, keselamatan pasien, serta pengembangan kompetensi tenaga keperawatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pelaksanaan yang dapat menjadi acuan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab komite keperawatan secara efektif dan akuntabel.

Pengelolaan pelaksanaan komite keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Perencanaan program kerja
 - 1) Menyusun rencana kerja tahunan komite keperawatan sesuai visi, misi, dan tujuan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 2) Menetapkan sasaran, indikator kinerja, jadwal kegiatan, serta kebutuhan sumber daya yang diperlukan.
2. Pelaksanaan fungsi kredensial
 - 1) melakukan proses kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan.
 - 2) menilai kompetensi, kualifikasi, pengalaman, dan kewenangan klinis tenaga keperawatan.
 - 3) memberikan rekomendasi kewenangan klinis kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pemeliharaan dan peningkatan mutu profesi
 - 1) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga keperawatan secara berkelanjutan.
 - 2) Melakukan audit keperawatan, telaah kasus, dan evaluasi praktik profesional.
 - 3) Mendorong partisipasi tenaga keperawatan dalam pendidikan dan pelatihan.
4. Pembinaan etika dan disiplin profesi
 - 1) Melakukan sosialisasi dan implementasi kode etik keperawatan.
 - 2) Menangani pengaduan, pelanggaran etik, dan masalah disiplin profesi.
 - 3) Memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kasus etik dan disiplin.
5. Monitoring dan evaluasi
 - 1) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerja komite keperawatan secara berkala.
 - 2) Mengevaluasi pencapaian indikator kinerja dan efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - 3) Menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
6. Koordinasi dan komunikasi
 - 1) Berkoordinasi dengan manajemen, bidang keperawatan, komite medis, serta unit terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komite keperawatan.

-
- 2) Menjalin komunikasi yang efektif untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan keperawatan.

7. Pelaporan dan dokumentasi

- 1) Menyusun laporan kegiatan komite keperawatan secara berkala, baik bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan.
- 2) Mendokumentasikan seluruh kegiatan, hasil kredensial, audit, pembinaan, serta evaluasi sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan.

Pedoman kerja ini memberikan panduan bagi komite keperawatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga serta meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit melalui mekanisme kredensial, pemeliharaan mutu profesi, serta pembinaan etika dan disiplin profesi. Pedoman kerja ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan komite keperawatan guna memastikan bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dilakukan oleh tenaga keperawatan yang kompeten, profesional, beretika, dan sesuai dengan kewenangan klinis yang dimiliki. Ruang lingkup pelaksanaan komite keperawatan meliputi:

1. Pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan.
2. Penilaian dan rekomendasi kewenangan klinis (clinical privilege) tenaga keperawatan.
3. Pemeliharaan dan peningkatan mutu profesi keperawatan.
4. Audit praktik profesional keperawatan.
5. Monitoring dan evaluasi kompetensi tenaga keperawatan.
6. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga keperawatan.
7. Pembinaan etika profesi keperawatan.
8. Penanganan masalah etik dan disiplin profesi keperawatan.
9. Monitoring kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan standar asuhan keperawatan.
10. Pemberian rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit terkait profesionalisme dan kewenangan klinis tenaga keperawatan .
11. Dokumentasi , pelaporan, monitoring, dan evaluasi seluruh kegiatan komite keperawatan

BAB II

ORGANISASI KOMITE KEPERAWATAN

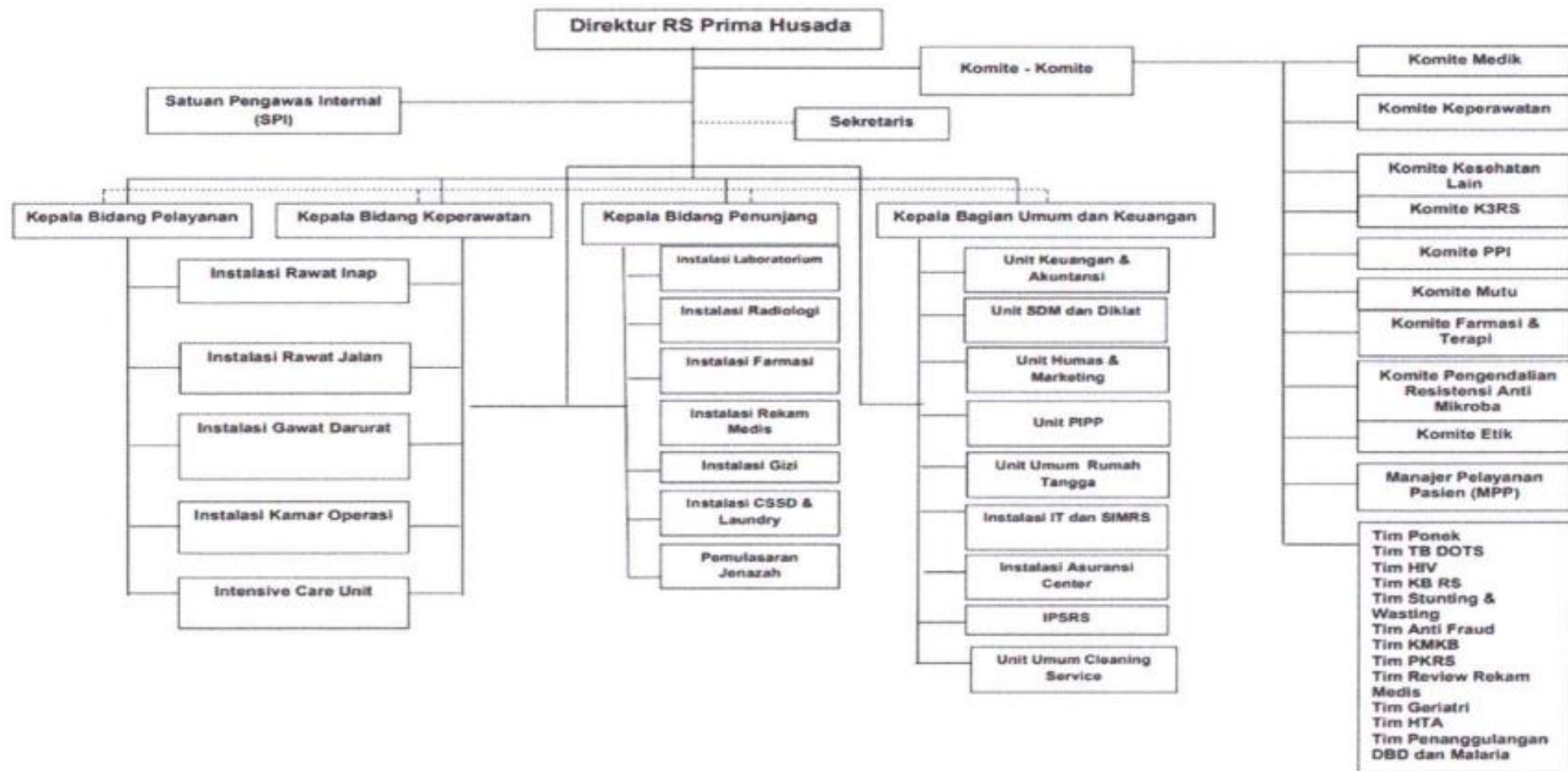
Organisasi komite keperawatan disusun untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pelayanan keperawatan di rumah sakit. Komite keperawatan dibentuk sebagai wadah profesional yang menjalankan fungsi kredensial, pemeliharaan mutu profesi, serta pembinaan etika dan disiplin profesi guna menjamin terselenggaranya pelayanan keperawatan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien

Bagi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya nomenklatur komite keperawatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, serta kemampuan fasilitas yang dimiliki. Namun demikian, pelaksanaan fungsi komite keperawatan harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip profesionalisme keperawatan, kredensial, peningkatan mutu profesi, dan pembinaan etika serta disiplin profesi keperawatan.

2.1 struktur organisasi

Pimpinan dalam komite keperawatan diberikan kewenangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan program kerja komite keperawatan.

Gambar 2.1 kedudukan komite keperawatan dalam struktur organisasi



Berdasarkan skema di atas maka kedudukan komite keperawatan berada langsung di bawah direktur Rumah Sakit

Gmabar 2.2 Struktur Organisasi Komite Keperawatan



dr. Resti Lestantini, M. Kes

1. Ketua Komite Keperawatan

Kriteria

- 1. Berpendidikan minimal ners atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Memiliki pengalaman kerja di bidang keperawatan minimal 5 (lima) tahun.
- 3. Memiliki kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang baik.
- 4. Memahami konsep kredensial, mutu profesi, etika dan disiplin profesi keperawatan.
- 5. Memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.
- 6. Mendapat rekomendasi dari bidang keperawatan dan persetujuan direktur rumah Sakit.

Uraian Tugas

1) Tugas Umum

- a. Membantu direktur dalam menyusun standar profesi keperawatan dan memantau pelaksanaannya.
- b. Memberikan masukan kepada direktur rumah sakit terkait upaya – upaya peningkatan pelayanan keperawatan di rumah sakit.
- c. Merencanakan program dan anggaran komite keperawatan, pembinaan, penilaian, pengembangan baik tata laksana kerja tugas-tugas dan karyawan, peningkatan kinerja dan mutu pelayanan keperawatan.
- d. Menetapkan pembagian tugas, batas-batas tugas, tanggung jawab, kewenangan hubungan kerja yang jelas bagi karyawan sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing.
- e. Mengkoordinasi pengurus komite keperawatan yang terdiri dari sub kredensial, sub mutu profesi dan sub etik dan disiplin profesi.

-
- f. Memberi pengarahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan guna tercapai tujuan pelayanan secara efektif dan efisien dalam suasana kerja yang kondusif.
 - g. Melakukan pengawasan/pengontrolan mencakup tugas: meneliti, menganalisis pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan, menilai hasil pekerjaan dan mengoreksi, merevisi pekerjaan guna tercapai tujuan akhir pelayanan (kepuasan pelanggan) sesuai rencana yang telah ditetapkan.
 - h. Melakukan koordinasi dengan unit atau penanggung jawab program lain dan manajemen

2) Tugas Khusus

- a. Menyusun program kerja tahunan yang berorientasi pada terjaminnya mutu profesi keperawatan.
- b. Menyusun pedoman pengorganisasian komite keperawatan.
- c. Menyusun panduan kerja komite keperawatan
- d. Merencanakan atau melaksanakan pelatihan dalam lingkup keperawatan dan kebidanan.
- e. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan logbook
- f. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial
 - 1. Ijazah
 - 2. Surat Tanda Registrasi [STR]
 - 3. Sertifikat kompetensi
 - 4. Logbook yang berisi uraian capaian kinerja
 - 5. Surat pernyataan telah menyelesaikan program orientasi rumah sakit atau orientasi unit tertentu bagi tenaga keperawatan baru
 - 6. Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan.
- g. Merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan ;
- h. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis ;
- i. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan
- j. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada kepala /direktur rumah sakit

Tanggung Jawab

- 1 menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan atau target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit.
- 2 menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas
- 3 mensupervisi dan mengkoordinasi bagian-bagian pelayanan. 4 melakukan pengawasan dan pengontrolan bidang pelayanan keperawatan

Wewenang

-
1. Pengkoordinasian dan pengawasan kegiatan
 2. Penyusunan rencana kerja tahunan
 3. Pengarahan dan pengaturan tugas
 4. Memimpin rapat
 5. Merekomendasikan kewenangan staf klinis keperawatan berdasarkan hasil proses kredensial.
 6. Merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesionalisme berkelanjutan berdasarkan asesmen kompetensi.

2. Sekretaris

Kriteria

1. Merupakan tenaga keperawatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Memiliki surat tanda registrasi (str) yang masih berlaku.
3. Memiliki integritas, tanggung jawab, dan etika profesi yang baik.
4. Mampu menjaga kerahasiaan data dan informasi organisasi.
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik lisan maupun tulisan.
6. Mampu bekerja secara sistematis, teliti, dan terorganisir.
7. Tidak sedang menjalani sanksi disiplin profesi maupun kepegawaian.

Uraian Tugas

1. Menyusun jadwal kegiatan komite keperawatan setiap awal periode kepengurusan bersama dengan ketua komite keperawatan.
2. Mengelola dokumentasi komite keperawatan termasuk arsip, ekspedisi surat masuk dan surat keluar.
3. Mengatur penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan komite keperawatan agar proses kegiatan berjalan dengan lancar.
4. Mencatat, menyimpan & melaporkan setiap kegiatan komite keperawatan
5. Mengelola kantor komite keperawatan

Tanggung Jawab

1. Menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
2. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas
3. Membantu ketua komite keperawatan dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan komite keperawatan

Wewenang

1. Pelaporan
2. Pengarahan

3. Sub Komite Mutu

Kriteria

1. Memiliki pengetahuan tentang peningkatan mutu pelayanan keperawatan.
2. Memahami standar asuhan keperawatan dan keselamatan pasien.
3. Memiliki kemampuan melakukan audit keperawatan dan evaluasi praktik profesional.
4. Aktif dalam kegiatan pengembangan profesi dan peningkatan kompetensi.

Uraian Tugas

1. Membuat rencana kerja atau program kerja sub komite mutu
2. Melakukan audit keperawatan
3. Mengembangkan diklat
4. Melakukan monitoring dan evaluasi program
5. menyusun program proses pendampingan/perseptor sesuai kebutuhan.

Tanggung Jawab

1. Menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
2. menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas

Wewenang

1. Melakukan monev penyelenggaraan program sub komite mutu profesi
2. Memberikan laporan pelaksanaan mutu profesi kepada ketua komite keperawatan.

4. Sub Komite Kredensial

Kriteria

1. Memiliki pengalaman klinis sesuai bidang keahlian.
2. Memahami proses kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan.
3. Memiliki kemampuan melakukan penilaian kompetensi tenaga keperawatan.
4. Memahami standar praktik profesional keperawatan dan kewenangan klinis.

Uraian tugas

1. Menyusun program kerja sub komite kredensial
2. Menyusun pedoman kredensialing staf keperawatan
3. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis (rkk)
4. Menyusun jadwal kredensial
5. Melakukan proses kredensial dan re-kredensial
6. Melakukan mapping staf keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis

7. Menyusun program orientasi

Tanggung jawab

1. Menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
2. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas

Wewenang

1. Membuat laporan pelaksanaan kredensial pada ketua komite keperawatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kredensialing

5. Sub komite etik

Kriteria

1. Memahami kode etik perawat Indonesia.
2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait praktik keperawatan.
3. Memiliki kemampuan melakukan pembinaan, mediasi, dan penyelesaian masalah etik.
4. Memiliki rekam jejak profesional yang baik dan menjadi teladan bagi tenaga keperawatan lainnya.

Uraian tugas

1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi staf keperawatan
2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi staf keperawatan
3. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan dan kebidanan
4. Memberikan laporan pelaksanaan mutu profesi kepada ketua komite keperawatan
5. Mengelola mekanisme masalah etik
6. Pemulihan nama baik
7. Mekanisme ijin penelitian
8. Mekanisme perlindungan hukum

Tanggung jawab

1. Menetapkan rencana kerja komite keperawatan sesuai tujuan dan target pelayanan yang ingin dicapai rumah sakit
2. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas

Wewenang

1. Merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam pemberian asuhan keperawatan dan kebidanan.
2. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis dan surat penugasan klinis

-
3. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

2.2 sarana dan fasilitas pelayanan penunjang komite keperawatan

1. Sarana kesekretariatan

- a. Ruangan sekretariat komite keperawatan serta tenaga sekretaris yang bertugas secara penuh sesuai kebutuhan
- b. Sarana komunikasi berupa telepon
- c. Sarana penunjang kesekretariatan lainnya yang mendukung kelancaran administrasi komitekeperawatan

2. Dukungan manajaemen

- a. Penetapan surat keputusan (sk) direktur tentang komite keperawatan
- b. Penyediaan anggaran untuk mendukung kegiatan komite keperawatan, yang meliputi:
 1. Pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga keperawatan dan anggota komite keperawatan
 2. Pengadaan sarana dan fasilitas penunjang kegiatan komite keperawatan.
 3. Pelaksanaan program kerja, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, dan rapat rutin komite keperawatan.
 4. Pemberian remunerasi, insentif, tunjangan, atau penghargaan bagi anggota komite keperawatan sesuai kebijakan rumah sakit.

3. Kebijakan Dan Standart Prosedur Operasional (SPO)

- a. Organisasi komite keperawatan terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang mencakup subkomite kredensial, subkomite mutu profesi, serta subkomite etik dan disiplin profesi.
- b. Rumah sakit menetapkan tenaga keperawatan yang memiliki kompetensi sesuai sebagai bagian dari komite keperawatan sesuai kebutuhan dan kapasitas rumah sakit
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite keperawatan didukung oleh unit keperawatan serta unit terkait dalam fasilitas pelayanan kesehatan.
- d. Kedudukan komite keperawatan secara fungsional berada di bawah direktur rumah sakit dan secara profesional berkoordinasi dengan bidang keperawatan.
- e. Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional development) bagi tenaga keperawatan dan anggota komite keperawatan.
- f. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia keperawatan melalui pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- g. Kebijakan tentang pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan secara berkala.
- h. Kebijakan tentang kewenangan klinis (clinical privilege) tenaga keperawatan berdasarkan hasil kredensial.

- i. Kebijakan tentang standar asuhan keperawatan dan keselamatan pasien.
- j. Kebijakan tentang pelaksanaan audit keperawatan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan.
- k. Kebijakan tentang penanganan kasus etik dan disiplin profesi keperawatan.
- l. Kebijakan tentang pelaksanaan surveilans mutu pelayanan keperawatan dan indikator kinerja keperawatan.
- m. Kebijakan tentang pemanfaatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dalam praktik keperawatan.
- n. Kebijakan tentang pengelolaan risiko dalam pelayanan keperawatan.
- o. Kebijakan tentang pelaporan, monitoring, dan evaluasi kegiatan komite keperawatan secara berkala.

2.3 Pengembangan Dan Pendidikan

1. Komite Keperawatan

- a. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait kredensial, mutu profesi, serta etika dan disiplin keperawatan.
- b. Memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang tugas komite keperawatan.
- c. Mengikuti seminar, workshop, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya secara berkelanjutan.
- d. Melakukan pengembangan kompetensi melalui bimbingan teknis dan kegiatan ilmiah secara rutin.

2. Tenaga Keperawatan Rumah Sakit

- a. Seluruh tenaga keperawatan wajib memahami prinsip profesionalisme, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien.
- b. Tenaga keperawatan yang memberikan pelayanan langsung wajib mengikuti pelatihan dasar dan lanjutan sesuai bidangnya.
- c. Rumah sakit secara berkala menyelenggarakan sosialisasi, refreshment, dan simulasi terkait standar praktik keperawatan.
- d. Setiap tenaga keperawatan baru wajib mengikuti program orientasi termasuk
- e. Materi tentang komite keperawatan, etika profesi, dan keselamatan pasien.

BAB III KEGIATAN DAN TATA LAKSANA

3.1 Batasan – Batasan Dalam Pelaksanaan Komite Keperawatan

1. Kompetensi Tenaga Keperawatan

Kemampuan tenaga keperawatan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai standar profesi dan kewenangan klinis yang ditetapkan.

2. Kredensial keperawatan

Proses verifikasi dan evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Kewenangan klinis (clinical privilege)

Hak khusus yang diberikan kepada tenaga keperawatan untuk melakukan tindakan keperawatan tertentu berdasarkan hasil kredensial.

4. Mutu profesi keperawatan

Tingkat kesesuaian praktik keperawatan terhadap standar profesi, standar prosedur operasional, serta indikator mutu pelayanan keperawatan.

5. Etik dan disiplin profesi keperawatan

Penerapan nilai moral, kode etik, serta aturan kedisiplinan yang mengatur perilaku tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

6. Insiden keperawatan

Setiap kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi dalam proses asuhan keperawatan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera pada pasien.

7. Audit keperawatan

Kegiatan evaluasi sistematis dan objektif terhadap dokumentasi dan pelaksanaan asuhan keperawatan untuk menilai kesesuaian terhadap standar yang berlaku.

3.2 Kegiatan Pelaksanaan Komite Keperawatan

1. Kegiatan Kredensial

- 1) Verifikasi dokumen tenaga keperawatan (str, ijazah, sertifikat kompetensi).
- 2) Penilaian kompetensi klinis melalui portofolio, wawancara, dan evaluasi kinerja.
- 3) Penetapan kewenangan klinis (clinical privilege).
- 4) Rekomendasi penugasan klinis kepada direktur rumah sakit.
- 5) Rekredensial Secara Berkala Untuk Evaluasi Ulang Kompetensi.

2. Kegiatan Mutu Profesi Keperawatan

- 1) Audit asuhan keperawatan secara berkala.
- 2) Evaluasi kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SPO).
- 3) Monitoring indikator mutu keperawatan (misalnya dokumentasi keperawatan, kejadian jatuh, dekubitus).
- 4) Telaah kasus keperawatan (case review) pada kasus risiko tinggi.
- 5) Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan, Seminar, Dan Workshop.

3. Kegiatan etik dan disiplin profesi

- 1) Sosialisasi kode etik keperawatan.
- 2) Penanganan pengaduan atau pelanggaran etik dan disiplin.
- 3) Klarifikasi dan investigasi kasus etik keperawatan.
- 4) Rekomendasi pembinaan atau sanksi sesuai ketentuan.
- 5) Monitoring kepatuhan terhadap etika profesi dan standar pelayanan.

3.3 Tatalaksana Komite Keperawatan

1. Tatalaksana kredensial

- a. Pengajuan berkas tenaga keperawatan oleh unit kerja.
- b. Verifikasi dokumen oleh subkomite kredensial.
- c. Penilaian kompetensi melalui asesmen.
- d. Penetapan rekomendasi kewenangan klinis.
- e. Penandatanganan dan pengesahan oleh direktur rumah sakit.

2. Tatalaksana mutu profesi

- a. Pengumpulan data indikator mutu keperawatan dari unit pelayanan.
- b. Analisis data oleh subkomite mutu profesi.
- c. Identifikasi masalah mutu pelayanan keperawatan.
- d. Penyusunan rekomendasi perbaikan (quality improvement).
- e. Monitoring tindak lanjut perbaikan mutu secara berkala.

3. Tatalaksana etik dan disiplin profesi

- a. Penerimaan laporan atau pengaduan kasus.
- b. Klarifikasi awal terhadap pihak terkait.
- c. Investigasi oleh tim etik dan disiplin.
- d. Sidang etik bila diperlukan.
- e. Penetapan rekomendasi pembinaan atau tindakan disiplin.
- f. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan etik.

4. Tatalaksana monitoring dan evaluasi

- a. Monitoring dilakukan secara rutin (bulanan/triwulan).
- b. Evaluasi dilakukan minimal setiap semester dan tahunan.
- c. Hasil evaluasi disampaikan kepada direktur rumah sakit.
- d. Penyusunan rencana tindak lanjut (rtl) berdasarkan hasil evaluasi.
- e. Perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pelayanan keperawatan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

Monitoring dilakukan oleh seluruh anggota komite keperawatan

4.2 Evaluasi

Rapat evaluasi dilakukan oleh komite keperawatan setiap sebulan sekali. Rapa antara sub komite dilakuakn minimal 3 bulan sekali.

4.3 Laporan

Laporan komite keperawatan secara menyeluruh disusun setiap 3 bulan sekali dan disampaikan kepada direktur rumah sakit .

Ditetapkan Di Malang
Pada Tanggal 06 Agustus 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr.Nur Mazidah